

KC桌面——外资精译

日本医疗保健：制药业：ASCO 2026：聚焦小野药品/武田药品管线药物，第一三共/安斯泰来竞争对手

我们重点介绍2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会对我们日本制药业覆盖范围的影响。临床试验数据披露了（1）小野药品的ONO-4578和IBI363（TAK-928）（武田药品正与信达生物合作开发该药），以及（2）第一三共的Datroway和安斯泰来的setidegrasib的竞争疗法。

虽然ONO-4578的结果总体上是积极的，但亚组分析（我们注意到这是一项受试者数量较少的探索性分析）表明，显示高效的患者群体可能有限。因此，我们认为建立或确认对该药物的进一步预期可能需要时间。关于IBI363（TAK-928）和sac-TMT（Datroway的潜在竞争对手），我们的观点与摘要（美国时间5月21日发布；我们的观点见本报告）披露的内容相比没有重大变化。daraxonrasib（setidegrasib的潜在竞争对手）披露了有利数据。虽然这目前并未改变我们对setidegrasib的看法，但我们认为需要密切监测这两种药物的开发趋势。

以下我们总结了日本制药业覆盖范围内公司的管线药物、竞争产品以及我们的观点。

小野药品（4528.T）：ONO-4578 2期试验

与安慰剂联合组相比，选择性EP4拮抗剂ONO-4578在联合纳武利尤单抗（Opdivo）+化疗联合疗法（当前标准疗法）用于一线胃癌治疗（在日本、韩国和台湾地区）的2期试验中，显示出无进展生存期（PFS）的统计学显著延长。临床获益在PD-L1阳性（CPS ≥ 1 ）组中更为明显。另一方面，在CPS < 1 或不确定的患者中未见明确获益（链接），并且在ONO-4578联合组中，PFS、总生存期（OS）和总缓解率（ORR）显示出恶化趋势（链接，仅日文）。此外，在Claudin

18.2阳性患者中，改善幅度趋于较小（链接，仅日文）。小野药品计划今年启动一项针对胃癌的全球3期试验。

尽管我们认为这是总积极性的进展，但亚组分析表明，高效的患者群体可能有限（注：这是一项受试者数量较少的探索性分析）。我们认为有必要等待更多数据和3期试验结果，以建立或确认对ONO-4578的进一步预期。

ONO-4578-08试验（#4007，摘要，发布）

■ 适应症：未经化疗、不可切除的晚期或复发性胃癌

试验概述：纳武利尤单抗联合化疗，加用ONO-4578（n=150）或安慰剂（n=76）疗效：ONO-4578联合组的中位PFS为9.0个月，安慰剂联合组为6.9个月（P=0.040，风险比[HR]为0.67）；ONO-4578联合组的中位OS未达到，安慰剂联合组为12.7个月（HR为0.60）；ORR为62.0%对比48.7% 在PD-L1阳性（CPS ≥ 1 ）亚组中，中位PFS为9.9个月对比5.7个月（HR为0.52），中位OS未达到对比12.7个月（HR为0.44），ORR为70.9%对比50.9% 在PD-L1阴性（CPS < 1 或不确定）亚组中，未见明确获益 ■ 安全性：未发现新的安全性问题

武田药品（4502.T）：信达生物公布IBI363（TAK-928）1期试验结果

合作公司信达生物公布了IBI363（TAK-928）在PD-L1低表达（TPS 1-49%）和PD-L1阴性（TPS $< 1\%$ ）的一线（1L）非小细胞肺癌（NSCLC）中的结果，该药有望重新激活肿瘤特异性T细胞。无论亚组如何，包括（1）组织学分类（非鳞状、鳞状）和（2）PD-L1表达水平，均确认了疗效。

我们不认为这些结果会促使我们对自摘要（链接）披露以来所持观点做出任何重大改变，我们还将关注美国2期试验（NCT06281678）的数据公布。关于我们中国团队的观点，请参阅链接报告。

TAK-928（IBI363）

1期剂量优化试验（#8586，摘要，发布）

■ 适应症：1L NSCLC ■ 疗效：在3-1.5 mg/kg组（n=22；第一周期IBI363 3 mg/kg + PDC，随后Q3W 1.5 mg/kg + PDC）中，确认的ORR为81.8%。在该组中，鳞状NSCLC（n=14）的ORR为78.6%，非鳞状NSCLC（n=8）的ORR为87.5%，PD-L1阴性患者（n=13）的ORR为76.9%。安全性：在3-1.5 mg/kg组中，与IBI363相关的3级或以上不良事件比例为43.5%，在1.5 mg/kg组中为50.0%，在3 mg/kg组中为69.0%。

- 推荐剂量：基于对临床试验结果的综合评估，3-1.5 mg/kg方案是1L NSCLC的推荐剂量。

sac-TMT 3期试验结果对第一三共（4568.T）的影响

公布了管线药物sac-TMT（靶向TROP2的抗体药物偶联物）在中国的一线NSCLC适应症试验数据，该药是Datroway（Dato-DXd）的潜在竞争对手，我们预计Datroway将成为第一三共的中长期增长驱动力。关于我们中国团队对OptiTROP-Lung05试验结果的看法，请参阅链接报告。对于sac-TMT的全球开发，我们正在关注由默沙东主导的TroFuse项目的进展。

尽管竞争药物的数据有利，但我们认为Datroway不仅可以在疗效上，还可以在安全性和便利性上实现差异化。展望未来，在一线NSCLC中，我们将关注以下试验结果的披露：（1）AVANZAR试验，针对TROP2生物标志物阳性患者（数据预计在2026年下半年公布）；（2）TROPION-Lung07试验，针对PD-L1表达率（TPS）低于50%的患者（sac-TMT相应的TroFuse试验目前尚未披露）；（3）TROPION-Lung08试验，针对TPS为50%或以上的患者（sac-TMT的TroFuse-07试验针对PD-L1高表达患者）。

sac-TMT（科伦博泰/默沙东）

OptiTROP-Lung05试验（#8506，摘要，发布）

■ 适应症：PD-L1 TPS $\geq 1\%$ 的1L NSCLC 试验概述：sac-TMT + 帕博利珠单抗联合疗法（n=208）与帕博利珠单抗单药疗法（n=205）的比较
疗效：中位PFS未达到对比5.7个月（HR为0.35）。sac-TMT + 帕博利珠单抗组的OS显示出改善趋势（HR为0.55）。在PD-L1高表达（TPS $\geq 50\%$ ）病例中，中位PFS的HR为0.47；在PD-L1低表达（TPS 1-49%）病例中，HR为0.28。在非鳞状NSCLC中，中位PFS的HR为0.28；在鳞状NSCLC中，HR为0.44。安全性：sac-TMT最常见的3级或以上特别关注不良事件为中性粒细胞计数减少（17.3%）、贫血（9.1%）和口腔炎（5.3%）。

daraxonrasib 3期试验结果对阿斯泰来（4503.T）的影响

Revolution Medicines (RVMD) 的 daraxonrasib (RAS(ON) 多选择性抑制剂) 是 setidegrasib (一种靶向 KRAS G12D 的蛋白降解剂) 的潜在竞争对手，后者由阿斯泰来开发，用于胰腺癌 (PDAC) 和肺癌 (NSCLC)。在 ASCO 2026 上，daraxonrasib 在 PDAC 二线及以上治疗中的 3 期 RASolute 302 试验结果公布，显示出在高度未满足需求的 PDAC 领域具有良好疗效。

虽然我们目前对 setidegrasib 的看法未变，但我们认为有必要密切监测这两种药物的未来发展趋势，尤其是一线治疗中的临床试验结果（阿斯泰来目前正在针对携带 KRAS G12D 突变的转移性 PDAC 一线治疗开展一项全球 3 期试验 (NCT07409272)。RVMD 正在开展 daraxonrasib 用于转移性 PDAC 一线治疗的 RASolute303 试验，以及靶向 G12D 的 zoldonrasib 用于转移性 PDAC 一线治疗的 RASolute305 和 RASolute309 试验）。

daraxonrasib (RVMD)

3 期 RASolute 302 试验 (LBA5, 摘要, 新闻稿)

■ 适应症：既往经治的转移性胰腺导管腺癌 (PDAC) 试验概述：每日一次口服 daraxonrasib 300mg 对比研究者选择的化疗 ■ 疗效：OS（总生存期）：daraxonrasib 组中位 OS 为 13.2 个月，化疗组为 6.7 个月（HR 为 0.40）。KRAS G12D/V 突变患者的 OS HR 为 0.38。安全性：导致治疗中断的 TEAE 发生率在 daraxonrasib

组为 1.2%，化疗组为 11.2%。

目标价风险与方法论 - 小野药品工业

我们给予卖出评级。我们基于 12 年 DCF 模型的 12 个月目标价为 2,100 日元，假设 WACC 为 6%，终值增长率为 0%。主要上行风险包括：关键药物销售好于预期、管线药物进展、产品评估变化、随着试验数据发布对 Opdivo 适应症扩展/市场份额增长的预期变化、通过授权引进扩大管线，以及海外业务平台建设的进展。

目标价风险与方法论 - 武田药品工业

我们给予中性评级。我们基于 12 年 DCF 模型的 12 个月目标价为 5,600 日元，假设 WACC 为 6%，终值增长率为 0%。主要风险包括：关键药物销售好于/差于预期、药物开发暂停或延迟及产品评估变化、宏观环境影响（包括美国及其他国家药品定价/医疗体系变化）、与大型收购相关的财务风险出现和/或销售/利润低于预期。

目标价风险与方法论 - 第一三共

我们基于 12 年 DCF 模型的 12 个月目标价为 4,300 日元，假设 WACC 为 6%，终值增长率为 0%。我们给予买入评级。主要风险包括：关键药物销售弱于预期、药物开发暂停或延迟、产品评估变化、关于 ADC 业务的负面消息，以及宏观环境影响（包括全球药品价格和医疗体系变化，尤其是美国）。

目标价风险与方法论 - 安斯泰来制药

我们对安斯泰来给予买入评级。我们基于 12 年 DCF 模型的 12 个月目标价为 2,950 日元，假设 WACC 为 6%，终值增长率为 0%。主要风险包括：关键药物销售差于预期、药物开发暂停或延迟、产品评估变化、关于中期增长驱动因素 Padcev 和 Vyloy 的负面消息，以及宏观影响（包括全球（尤其是美国）药品价格和医疗体系变化）。

披露附录

Reg AC

本人 Akinori Ueda, Ph.D. 特此证明，本报告中所表达的所有观点均准确反映了我个人对相关公司及其证券的看法。我还证明，我的薪酬中没有任何部分直接或间接地与报告中表达的具体建议或观点相关。

撰稿作者：Akinori Ueda, Ph.D. GS Japan Co., Ltd., Tomo Taniguchi GS Japan Co., Ltd.。

GS 因子概况

GS 因子概况通过将股票的关键属性与市场（即我们的评级股票池）及其行业同行进行比较，为股票提供投资背景。所描绘的四个关键属性是：增长、财务回报、倍数（例如估值）和综合（增长、财务回报和倍数的复合指标）。增长、财务回报和倍数是使用每只股票特定指标的标准化排名计算得出的。然后将这些指标的标准化排名进行平均，并转换为相关属性的百分位数。每个指标的具体计算可能因财年、行业和地区而异，但标准方法如下：

增长基于股票的前瞻性销售增长、EBITDA 增长和 EPS 增长（对于金融股，仅 EPS 和销售增长），百分位数越高表示公司增长越快。财务回报基于股票的前瞻性 ROE、ROCE 和 CROCI（对于金融股，仅 ROE），百分位数越高表示公司财务回报越高。倍数基于股票的前瞻性 P/E、P/B、价格/股息 (P/D)、EV/EBITDA、EV/FCF 和 EV/债务调整后现金流 (DACF)（对于金融股，仅 P/E、P/B 和 P/D），百分位数越高表示股票交易倍数越高。综合百分位数计算为增长百分位数、财务回报百分位数和（100% - 倍数百分位数）的平均值。

财务回报和倍数使用 GS 分析师对未来至少三个季度后的财年末预测。增长使用的输入数据是未来至少七个季度后的财年末与未来至少三个季度后的财年末相比（所有指标均基于每股）。

有关我们如何计算 GS 因子概况的更详细说明，请联系您的 GS 代表。

M&A 排名

在我们的全球覆盖范围内，我们使用 M&A 框架审视股票，同时考虑定性因素和定量因素（可能因行业和地区而异），以纳入某些公司可能被收购的可能性。然后我们分配一个 M&A

排名，作为对我们评级覆盖范围内的公司进行评分的方法，评分范围为 1 到 3，其中 1

表示公司成为收购目标的可能性高（30%-50%），2 表示可能性中等（15%-30%），3

表示可能性低（0%-15%）。对于排名为 1 或 2 的公司，按照我们的标准部门指南，我们将 M&A

组成部分纳入我们的目标价。M&A 排名为 3

被认为不重要，因此不计入我们的目标价，并且可能在研究报告中讨论或不讨论。

Quantum

Quantum 是 GS 的专有数据库，可提供详细的财务报表历史、预测和比率。它可用于对单个公司进行深入分析，或比较不同行业和市场的公司。

披露

GS和/或其关联方正在就以下公司或其关联方已公布的战略事项担任财务顾问：第一三共株式会社

安斯泰来制药、第一三共、小野药品工业和武田药品工业的评级是相对于其覆盖范围内的其他公司而言的：安斯泰来制药、CUC、中外制药、第一三共、卫材、JMDC、协和麒麟、M3、奥林巴斯、小野药品工业、大冢HD、PeptiDream、参天制药、泽井集团HD、盐野义制药、希森美康、武田药品工业、泰尔茂

公司特定监管披露

截至最近第二个月末，GS实益拥有1%或以上普通股（不包括根据美国证券法无需合并的关联方和业务部门管理的头寸）：安斯泰来制药（¥2,170）、第一三共（¥2,583）和小野药品工业（¥2,217）

GS在过去12个月内因投资银行服务获得报酬：第一三共（¥2,583）和武田药品工业（¥4,850）

GS预计在未来3个月内将因投资银行服务获得报酬或寻求获得报酬：安斯泰来制药（¥2,170）、第一三共（¥2,583）、小野药品工业（¥2,217）和武田药品工业（¥4,850）

GS在过去12个月内因非投资银行服务获得报酬：第一三共（¥2,583）

GS在过去12个月内与以下公司存在投资银行服务客户关系：安斯泰来制药（¥2,170）、第一三共（¥2,583）、小野药品工业（¥2,217）和武田药品工业（¥4,850）

GS在过去12个月内与以下公司存在非投资银行证券相关服务客户关系：安斯泰来制药（¥2,170）、第一三共（¥2,583）和武田药品工业（¥4,850）

GS在过去12个月内与以下公司存在非证券服务客户关系：安斯泰来制药（¥2,170）、第一三共（¥2,583）和武田药品工业（¥4,850）

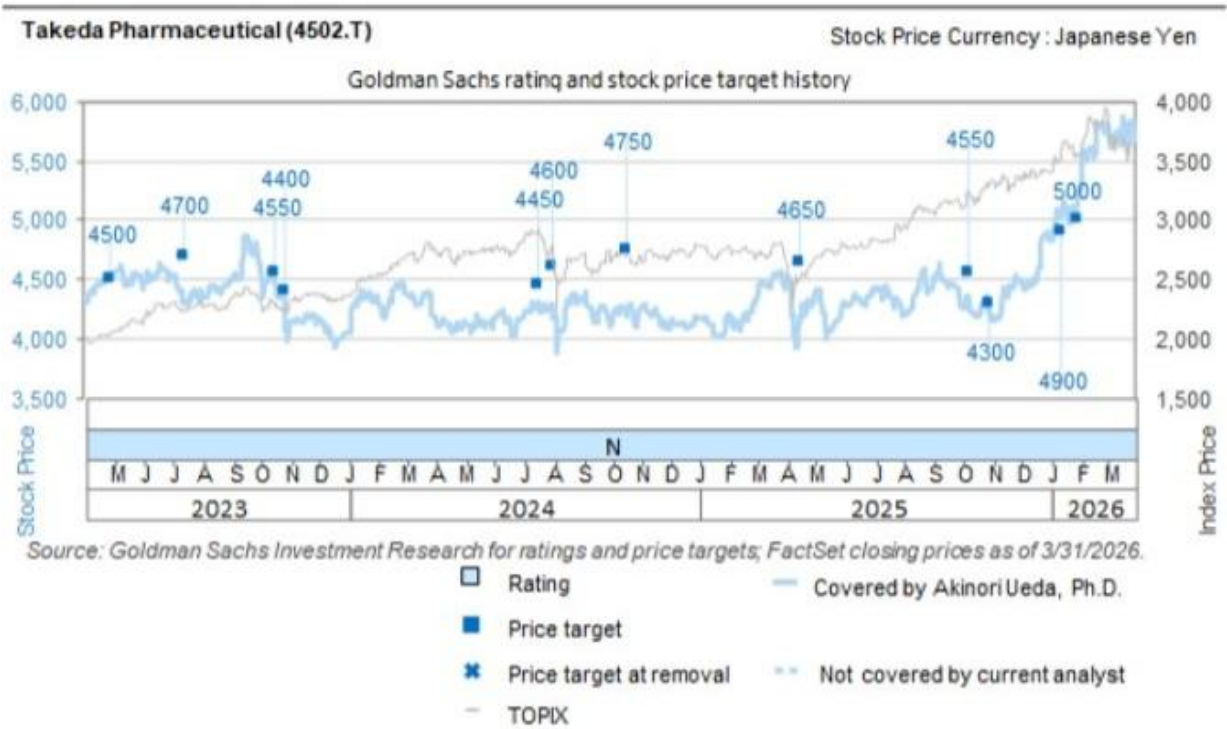
GS在过去12个月内管理或共同管理了一次公开发行或Rule 144A发行：第一三共（¥2,583）

GS做市于以下证券或其衍生品：武田药品工业（¥4,850）

评级/投资银行关系分布

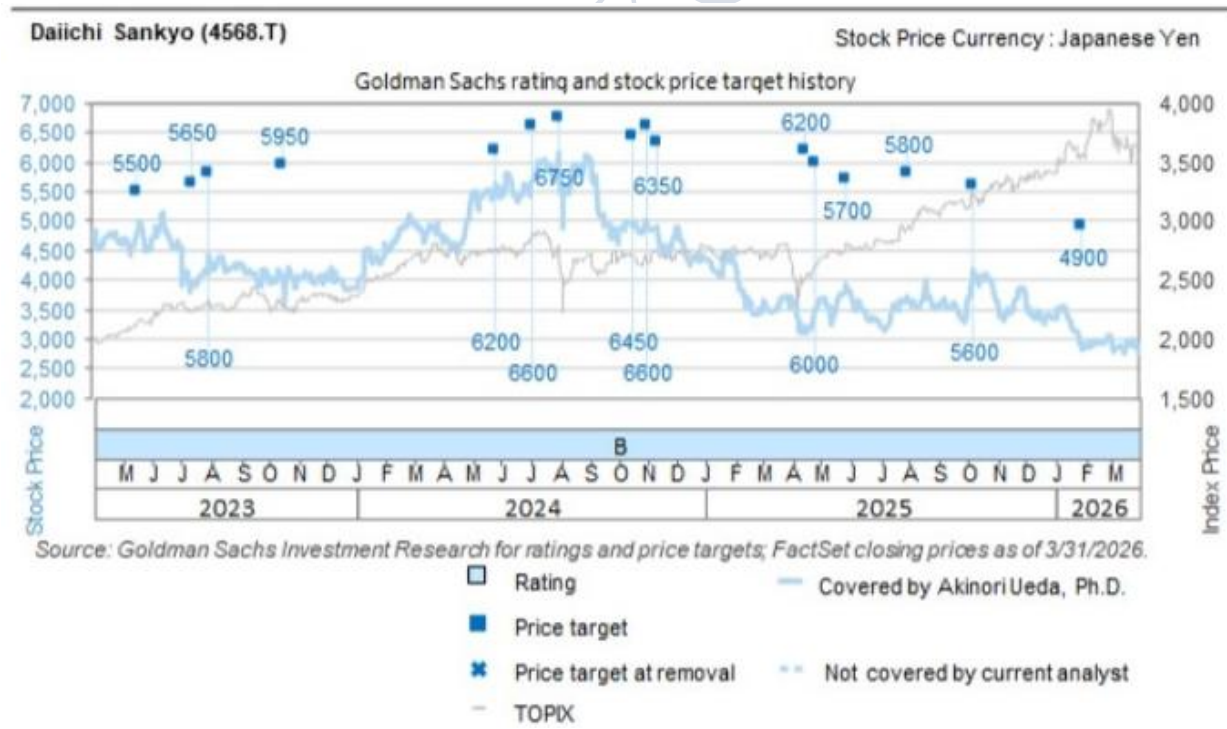
GS投资研究全球股票覆盖范围

目标价与评级历史图表



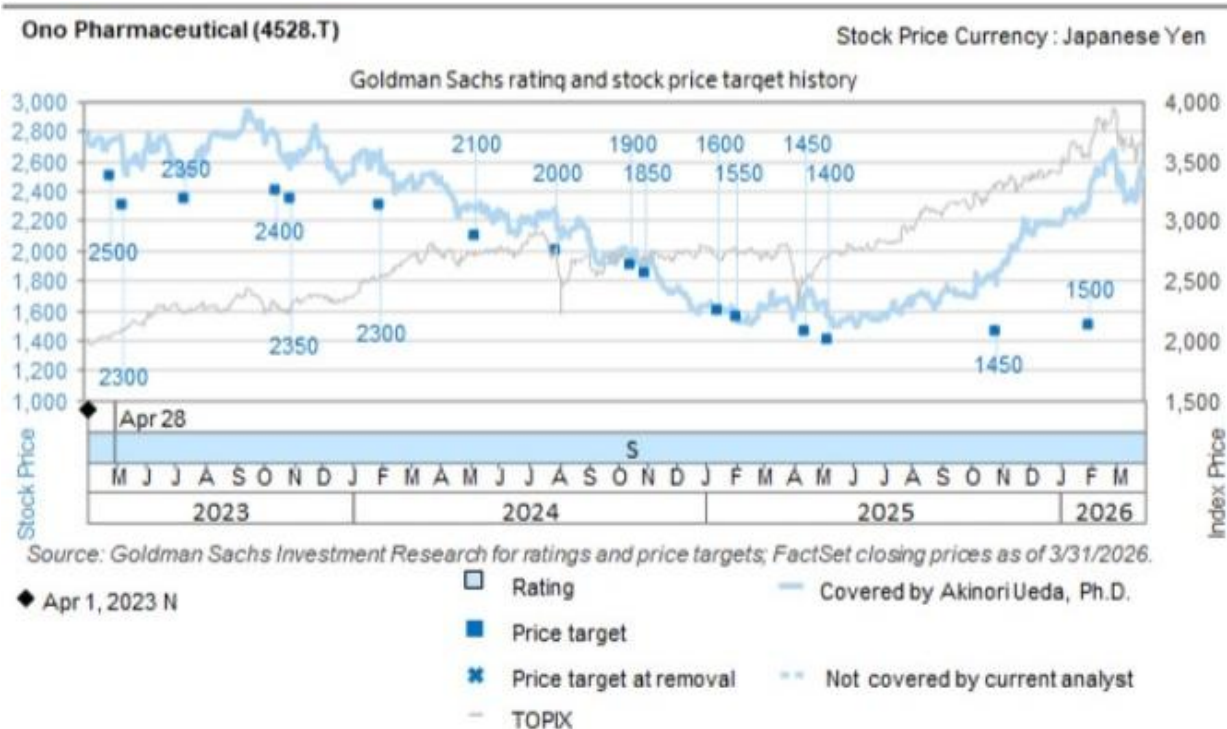
图表 1

所示目标价应结合所有先前已发布的GS报告（可能包含或不包含目标价）以及公司、行业和金融市场的发展情况来考虑。



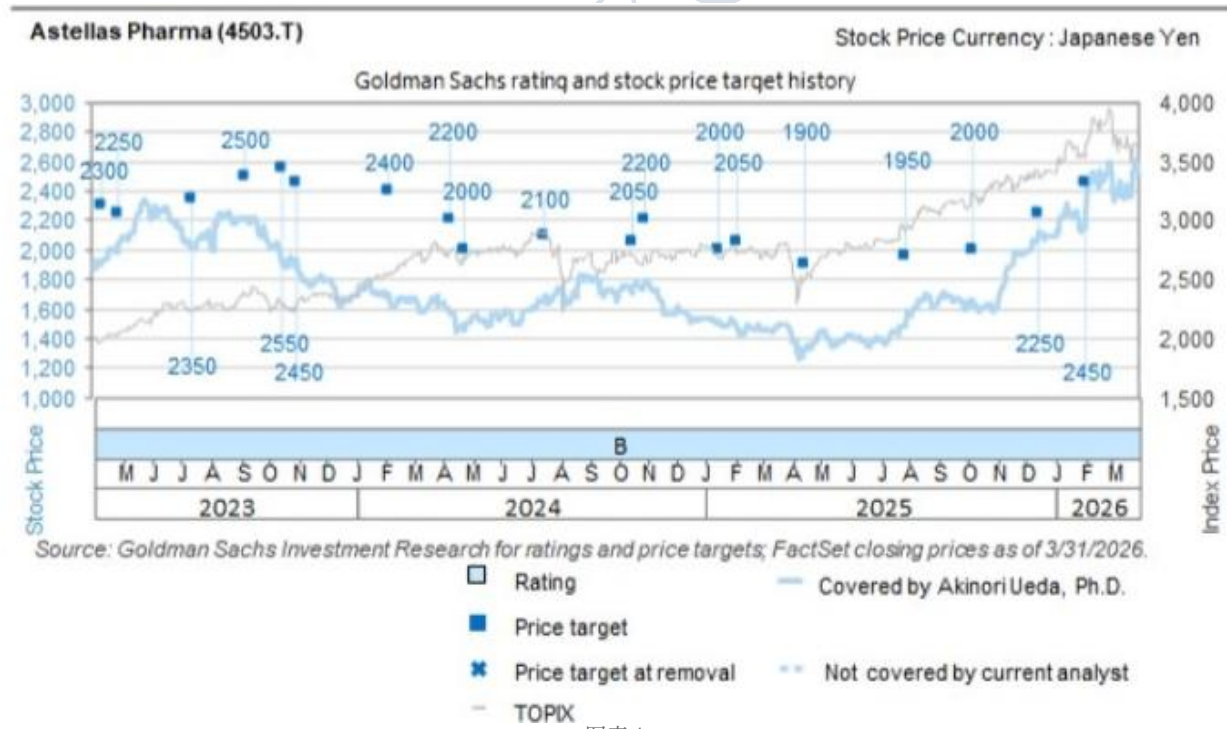
图表 2

所示目标价应结合所有先前已发布的GS报告（可能包含或不包含目标价）以及公司、行业和金融市场的发展情况来考虑。



图表 3

所示目标价应结合所有先前已发布的GS报告（可能包含或不包含目标价）以及公司、行业和金融市场的发展情况来考虑。



图表 4

所示目标价应结合所有先前已发布的GS报告（可能包含或不包含目标价）以及公司、行业和金融市场的发展情况来考虑。

目标价历史表格

武田药品工业 (4502.T)

小野药品工业 (4528.T)

武田药品工业 (4502.T)

小野药品工业（4528.T）

第一三共（4568.T）

安斯泰来制药（4503.T）

表格中所示目标价未针对公司行动进行调整。

公众号：KC桌面